

08 - 01-HEMORRAGIES GENITALES - Pr. ABOUFALAH

(0:03 - 0:38)

Bonjour, c'est le professeur Aboul Falah, du CHU de Marrakech, je suis gynécologue. Ce premier cours concerne les hémorragies génitales comme symptômes au syndrome en gynécologie. Les hémorragies génitales désignent tout saignement anormal d'origine génitale qui est différent du sens des règles et extériorisées à la vue.

(0:40 - 1:08)

Les ménorragies désignent des règles abondantes et ou prolongées. Les métrorragies désignent toutes hémorragies d'origine utérine survenant en dehors des règles. Mais souvent, les ménorragies s'associent à des métrorragies et on parle de ménométrorragies.

(1:09 - 1:52)

Les hémorragies génitales représentent un motif fréquent de consultations en gynécologie, puisqu'ils représentent un tiers des consultations chez le spécialiste. Il s'agit d'un symptôme qui peut révéler presque l'ensemble de la pathologie gynécologique et aussi obstétrique. Ainsi, ces hémorragies génitales peuvent intéresser tous les maillons de la filière génitale, de bas en haut, la vulve, le vagin, le colutérin, l'endomètre, les trompes et les ovaires.

(1:55 - 2:38)

Les causes de ces hémorragies génitales dépendent du terrain et on peut distinguer trois périodes de vie. Les hémorragies génitales péri-pubertaires, les hémorragies génitales de la période d'activité génitale qui s'étale de la puberté à la ménopause et les hémorragies génitales post-ménoposiques. L'enquête étiologique doit suivre une démarche rigoureuse afin d'éliminer une réelle urgence par l'abondance de ces hémorragies ou contre ces hémorragies mal tolérées.

(2:40 - 7:43)

Cette enquête doit rechercher systématiquement l'existence d'une grossesse et l'interrogatoire et l'examen gynécologique complet vont orienter vers un bilan paraclinique. Il faut toujours poser un diagnostic précis avant tout traitement. Il y a des diagnostics différentiels mais c'est rare des fois il y a une hématurie mais sur l'interrogatoire avec la présence des signes urinaires et l'examen des urines on peut facilement éliminer l'hématurie.

Des fois le diagnostic se pose avec les rectoragies là aussi au niveau de l'interrogatoire la présence de signes digestifs et l'examen aussi des selles. L'interrogatoire est un élément fondamental dans l'enquête étiologique donc il faut préciser l'âge de la patiente, sa gesticité, la parité le statut hormonal c'est très important parce qu'il va nous orienter vers l'éthéologie la puberté, la période d'activité génitale où la patiente est ménopausée. L'interrogatoire précise

les caractéristiques du cycle menstruel il va préciser la date des dernières règles élément très très très important.

Le mode de contraception si la patiente prend un moyen contraceptif parce que c'est une pilule, quel type de pilule c'est un stérilet. L'interrogatoire précise aussi la notion de prise médicamenteuse c'est très très important, type traitement hormonal s'il prend des anticoagulants qui peuvent expliquer l'hémorragie il va préciser les antécédents médico-chirurgical et gynéco-obstétrico et puis il faut préciser ou faire une analyse sémiologique du symptôme. Les circonstances d'apparition de ces saignements par rapport aux règles c'est quelque chose de très important.

Le type d'hémorragie génitale, est-ce que c'est des ménorragies ou des métrorragies où les deux associés on parle de ménorragie, est-ce que ces saignements sont spontanés ou provoqués, par exemple provoqués par la toilette intime ou les rapports sexuels et il va analyser aussi, il va préciser l'abondance de ces saignements, la couleur du sang la durée d'évolution et l'évolution par rapport au cycle C et puis il faut chercher toujours à l'interrogatoire s'il y a des symptômes associés type douleurs pélviques ou des locales, c'est-à-dire des pertes vaginales. L'examen général est très important, il doit éliminer une urgence vitale et doit évaluer le retentissement de cette hémorragie sur l'état général par la prise constante visuelle, la tension artérielle, le pouls, la fréquence respiratoire prendre la température, évaluer l'abondance de l'hémorragie et voir l'état général et l'état des conjonctives. L'examen gynécologique est très très important à la recherche d'une étiologie il faut d'abord commencer par une inspection de la région vulvopérinéale à la recherche d'une plaie traumatique qui peut expliquer le saignement ou d'une tumeur au niveau vulvopérinéale et préciser si elle est ulcérée ou bourgeonnante.

L'examen sous spéculum est très très important, il va préciser l'état du col utérin s'il y a une tumeur, une cervicite ou un ectropion qui peuvent expliquer le saignement. Et puis il ne faut pas oublier lors de l'examen sous spéculum de voir l'état du vagin à la recherche par exemple d'une tumeur vaginale, quoique c'est rare au niveau du vagin. Après l'inspection vulvopérinéale et l'examen sous spéculum il faut faire un touché vaginal associé au palpé abdominal pour préciser la taille de l'utérus le volume de l'utérus, sa sensibilité, sa mobilité et présence ou non d'une masse pelvienne.

(7:44 - 8:29)

Le touché rectal est fait chez la vierge et quand il y a un cancer utérin pour évaluer l'extension de ces cancers et puis quand il y a une masse pelvienne pour préciser les rapports postérieurs de la masse pelvienne. Les examens paracliniques sont toujours orientés par l'interrogatoire et l'examen clinique. Le 2-AGBT-ACG plasmatique est très très important pour éliminer une grossesse qu'il soit intra-utérine ou extra-utérine qui représente une rare urgence.

(8:30 - 8:52)

Un bilan sanguin, le groupage rhesus une numération et un bilan de moustase. Et puis l'échographie qui est un élément très très important parce qu'elle complète l'examen clinique. L'échographie pelvienne peut être faite par voie suspibienne mais c'est surtout la voie ondo-vaginale.

(8:53 - 16:30)

Il va préciser l'état de l'utérus, le volume utérin l'existence éventuelle d'un fibrome l'état de l'endomètre à la recherche d'un polype l'état d'un fibrome ou d'une hypertrophie ou d'une hyperplasie endométriale. Cette échographie va préciser l'existence ou l'absence d'une masse annexielle, c'est-à-dire tuber ou ovarienne. Des fois, quand l'échographie nous oriente vers une étiologie au niveau de l'endomètre on peut demander l'hystéroscopie diagnostique c'est l'élément clé pour préciser l'état de l'endomètre.

L'hystérosalpingographie on peut la demander pour voir la cavité utérine des trompes, mais cet examen est actuellement réservé uniquement dans le cadre de l'infertilité. On peut être amené à faire des prélèvements sito-histologiques, donc à chaque fois qu'on voit une tumeur à l'examen clinique, il faut faire une biopsie pour confirmer la nature de la tumeur avec l'étude histologique. Des fois, quand il y a une hypertrophie de l'endomètre, surtout chez la femme ménopausée où on suspecte un cancer de l'endomètre, on peut être amené à faire un courtage biopsique de l'endomètre, mais actuellement ce courtage biopsique de l'endomètre, il est fait au cours d'une hystéroscopie pour orienter le prélèvement.

On peut être amené à des fois à faire des dosages hormonaux ou une courbe ménothermique pour préciser le diagnostic. Le diagnostic théologique, il faut toujours s'aider entre les hémorragies génitales péri-pubertaires, les hémorragies génitales de la période d'activité génitale qui s'était de la puberté à la ménopause et durant cette période-là, il faut les séparer entre causes gravidiques c'est-à-dire liées à la grossesse et causes non-gravidiques et puis quand la patiente est ménopausée ces rubriques des hémorragies génitales post-ménopausiques. Concernant les hémorragies génitales péri-pubertaires elles sont dominées par les causes fonctionnelles mais c'est un diagnostic d'exclusion il faut toujours éliminer une cause organique avant de retenir une cause fonctionnelle hormonale.

Il faut faire très attention durant la période de la puberté à la possibilité de la grossesse, donc il faut éliminer même chez les jeunes filles la possibilité de grossesse. Il faut faire un examen complet des organes génitaux externes. Des fois on fait un examen suspiculant de vierge et le toucher vaginal il ne faut pas le faire parce qu'en général c'est des filles vierges et elle est remplacée par le toucher rectal puis on fait une échographie pelvienne parfois suspiculaire.

Quelles sont les causes organiques? Donc on peut trouver une vulvite une vulvo-vaginite, souvent secondaire à un oxy-rose où des fois il faut rechercher si la petite fille a un corps étranger puis il faut chercher si elle a des lésions vulvaires type polype des fois on a des tumeurs malignes, surtout les sarcomes chez les jeunes filles, et puis l'adénose vaginale. Et si on exclut les causes organiques il faut chercher les causes fonctionnelles, surtout les troubles

des moustases qui peuvent être inaugurables d'un certain nombre de troubles de les moustases, mais c'est souvent dans la majorité des cas ces hémorragies surviennent dans le cadre d'une insuffisance lutéale par immaturité du système hypothalamo-épophyso-ovarien. Concernant les hémorragies génitales durant la période d'activité génitale qui sont d'origine gravidique c'est-à-dire liées à la grossesse, c'est pourquoi il faut toujours chercher une grossesse, il faut faire l'anamnèse préciser la date des dernières règles pour voir s'il y a un retard de règles ou pas. On peut être amené à faire un test de grossesse et l'échographie pelvienne pour éliminer une grossesse.

Maintenant quelles sont les causes des hémorragies du premier trimestre de la grossesse? La hantise chez les gynécologues et tous les médecins généralistes c'est d'éliminer une grossesse extra-utérine parce qu'il représente une réelle urgence. Par définition, si l'ovulation ectopique de l'oeuf, en général c'est au niveau de la trompe c'est une pathologie qui fréquente il représente 1 à 2% de grossesse et sur le plan clinique il faut chercher tous les facteurs de risque, la grossesse extra-utérine il faut voir s'il y a un retard de règles et en général il y a une métrorragie qui s'associe à des douleurs pelviennes et sur le plan paraclinique on fait un dosage de bêta-HCG plasmatique couplé à une échographie pelvienne pour asseoir le diagnostic et bien évidemment il représente une réelle urgence thérapeutique. À côté de la grossesse extra-utérine qui représente une véritable urgence, il y a la grossesse intra-utérine évolutive sur le retard de règles il y a une présence de signes sympathiques de la grossesse le collutérin est fermé l'utérus est augmenté de taille et l'échographie va préciser qu'il s'agit d'une grossesse intra-utérine évolutive et ces grossesses peuvent se nier par un décollement trophoblastique.

Puis il y a la grossesse AVT et là l'échographie confirme la présence de la grossesse mais avec l'activité cardiaque négative chez le fœtus et il y a des retentions de morts ou s'il y a un avortement en cours. Puis il y a une pathologie qui est relativement rare mais ça existe, la molle hidatiforme il s'agit d'une dégénérescence kystique des virosités coréales. Le diagnostic est posé sur le retard de règles avec la présence d'une métrorragie et c'est le couple échographie par voie endovaginale et le 2-HVACG pour asseoir le diagnostic de molle hidatiforme.

(16:32 - 20:31)

Concernant les hémorragies génitales de la période d'activité génitale et qui sont non-gravidiques, extra-gravidiques on peut trouver les causes vulvo-vaginales sous forme de plaies de tumeurs mais surtout les causes cervicales, le cancer du colutéra qui reste malheureusement fréquent dans notre contexte marocain et là la patiente elle va se plaindre d'une métrorragie et à l'examen on va voir la tumeur au niveau du col et qu'on doit la biopsier pour confirmer sa nature. On peut trouver au niveau du col un certain nombre de pathologies type polype un ectropion qui saigne et rarement, exceptionnellement une tuberculose cervicale. Puis les causes endo-utérines, endo-cavitaires sont dominées par le fibrome utérin et la patiente là en général elle a des ménorragies ou des ménométrorragies et le diagnostic il est fait par l'échographie surtout par voie endo-vaginale et confirmé par l'hystéroscopie.

Puis il y a la dénomios, c'est en fait, c'est l'implantation ectopique de l'endomètre au niveau du myomètre et va être responsable de ménorragies souvent associées à des disminorés, c'est à dire des douleurs au moment des règles et c'est une pathologie de la quarantaine. On peut trouver aussi un polype ou un cancer de l'endomètre surtout chez la femme ménopausée. Puis il y a les causes annexielles, les tumeurs ovariennes, sécrétantes et qui vont agir au niveau de l'endomètre et puis il y a des causes fonctionnelles mais ça représente toujours un diagnostic d'exclusion, un diagnostic d'élimination après avoir éliminé toutes les idéologies organiques.

Concernant les hémorragies génitales post-ménopausiques, ils sont représentés par le cancer de l'endomètre et qui va se manifester par des métrorragies post-ménopausiques, c'est le maître symptôme et toutes métrorragies post-ménopausiques doivent inciter à faire une échographie endovaginale pour voir l'état de l'endomètre, l'épaisseur de l'endomètre et ça doit déboucher sur un examen hystéroscopique avec un prélèvement au niveau de l'endomètre afin d'éliminer un cancer de l'endomètre et des fois on peut être amené à faire un courtage biopsychique de l'endomètre pour confirmer le diagnostic. Il y a d'autres cancers, c'est le cancer de la vulve, le cancer du vagin, le cancer du col, le cancer de l'ovaire. Donc là, la présence d'un saignement en post-ménopause, la hantise, c'est le cancer.

Et puis il y a un certain nombre de causes fonctionnelles qui restent toujours en diagnostic d'exclusion, type hyperplasie de l'endomètre ou une atrophie de l'endomètre qui peut saigner. Et puis il y a un certain nombre de causes héatrogènes, c'est pourquoi il faut chercher la prise d'un traitement hormonal. En conclusion, les hémorragies génitales sont un motif de consultation très fréquent, les étiologies sont nombreuses.

La hantise pour les médecins, c'est l'existence d'une grossesse qui soit normale ou non durant la période d'activité génitale. Et les cancers, essentiellement le cancer du col qui reste fréquent chez nous et le cancer de l'endomètre chez la femme post-ménopausique. C'est pourquoi il faut faire une démarche diagnostique rigoureuse afin de préciser la cause exacte afin de proposer un traitement adapté.